

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)

A Secretaria da Saúde de Joinville por meio da Coordenação de Saúde Mental informa que, a assistência em Saúde Mental no município está presente em todos os níveis da Rede de Atenção à Saúde: Unidade Básica de Saúde, Centro de Atenção Psicossocial, Pronto Atendimento e Unidade Hospitalar, sendo a condição clínica o fator determinante para a definição do nível de atenção.

Este material informativo, tem o intuito de **orientar adequadamente os munícipes** quanto ao Fluxo de Acesso à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no município de Joinville, bem como o Fluxo de Acesso às internações psiquiátricas.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) instituída pela Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, no art. 1º, descreve que a RAPS tem como “finalidade a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo Assistencial em Saúde Mental, as internações, em quaisquer de suas modalidades, só serão indicadas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Quando necessárias, as internações somente serão realizadas mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e deverão ser estruturadas de forma a oferecer assistência integral e adequada à pessoa com transtornos mentais.

A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe ainda no art. 6º, os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - Internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - Internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - Internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.



Importante:

A participação da família nesse processo é fundamental para o engajamento do usuário. Para isso, se faz necessário a participação dos familiares nos grupos de apoio.



A evolução clínica diante da intervenção terapêutica determinará a necessidade de internação, sendo o último recurso a ser utilizado, após esgotarem outras possibilidades terapêuticas. Para internação do usuário com demanda de transtorno ou sofrimento mental, incluindo aquele decorrente do uso de substâncias psicoativas, considera-se os seguintes passos:

- 1°
↓
O usuário e/ou a família DEVE procurar o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência e apresentar a demanda;
- 2°
↓
A equipe do CAPS realiza o acolhimento ao usuário e/ou familiar por meio da Escuta Qualificada e orienta sobre o tratamento e funcionamento do Serviço;
- 3°
↓
Caso o usuário não compareça para acolhimento, o CAPS realiza busca ativa (visita domiciliar/contato telefônico) para definição de conduta;
- 4°
↓
Com o consentimento do usuário para participar do atendimento no CAPS, o mesmo será vinculado ao Serviço e a equipe elabora o Projeto Terapêutico Singular (PTS), por meio do qual será definida a frequência das atividades, hospitalidade diurna e/ou noturna ou outros encaminhamentos pertinentes ao caso;
- 5°
↓
Caso a equipe técnica do serviço avalie a necessidade de internação involuntária, será agendada consulta médica para avaliação do usuário;
- 6°
↓
Médico confirma a necessidade de internação involuntária, preenche o encaminhamento e envia à Central de Regulação;
- 7°
↓
Médico da Central de Regulação avalia o encaminhamento e os critérios de elegibilidade para a internação involuntária;
- 8°
↓
Atendidos os critérios de elegibilidade para a internação involuntária, médico regulador solicita vaga de leito, via Sistema de Regulação Estadual (SISREG) e comunica a equipe do CAPS;
- 9°
↓
A equipe do CAPS informa usuário e/ou familiares sobre internação e transporte, assim como a articulação com a equipe da UBSF de referência do usuário, quando necessário;
- 10°
↓
Durante a internação, a família deve permanecer vinculada e atuante no processo do cuidado. Após alta da internação, é indicado que o usuário dê seguimento ao tratamento no CAPS.

